リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月1日（日）

第51号 朝刊

きょうの紙面 ▸ 脳卒中 × 経腸栄養 × 便秘 ▸ 痙縮 × 用語の定義 ▸ 作業療法 × 生成AI ▸ 短信 8本

■ 脳卒中 × 経腸栄養 × 便秘

経腸栄養中の脳卒中、64.4%が便秘 入院時の情報だけでは予測が難しい

神経ICU362人の後ろ向き解析　早期の情報だけの識別力AUC 0.629

脳卒中で経腸栄養を受けている患者の便秘を、機械学習でどこまで予測できるかを調べた後ろ向きの研究だ。Nursing in Critical Careの2026年11月号に載った。2019年12月～2023年12月に神経集中治療室へ入った362人のうち、233人（64.4%）に便秘の記載があった。

6つのアルゴリズムを比べ、最も識別力が高かったのはTabPFN-3だった。入院後の早い時点で得られる情報だけを使うと、ROC-AUCは0.629（95%CI 0.567～0.689）にとどまる。入院中の全情報を加えると0.771（0.715～0.820）まで上がるが、その情報は退院間際にならないとそろわない。患者は3群に分かれたが、分離は弱い（シルエット係数0.108）。

抄録に外部での検証の記載はなく、早期に高リスクの人を絞り込める精度ではない。経腸栄養中は全員で排便の経過を確認しておく、という見方が現実的だ。



全員で排便の経過を確認する。

出典 Nurs Crit Care ↗

数字で見る

64.4%
便秘の記載（362人中233人）

0.629
早期の情報だけのAUC

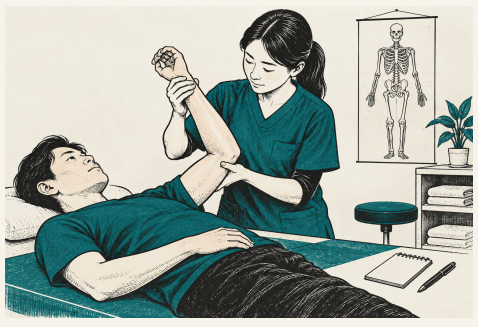
0.771
入院中の全情報を使ったAUC

■ 痙縮 × 用語の定義

痙縮の定義を国際専門家パネルが更新 速度・長さ依存の不随意の筋過活動

痙縮の定義が研究や臨床で一定でないとして、Spasticity X Working Groupの国際専門家パネルが修正Delphi法で新しい定義をまとめた。American Journal of Physical Medicine & Rehabilitationの2026年11月号に載っている。従来の定義は狭すぎるか、臨床に合っていないとされた。

新しい定義は「上位運動ニューロン疾患に起因する感覚運動制御の障害。受動伸張中の、速度



と長さに依存する不随意の筋過活動（断続的または持続的）を特徴とする」。専門家の合意による提案で、抄録に参加者数の記載はなく、評価尺度や治療についての推奨は示されていない。

出典 Am J Phys Med Rehabil ↗

■ 作業療法 × 生成AI

作業療法士の48.9%が生成AIを使用 施設の方針があるのは6.2%

米国の作業療法士277人と作業療法助手77人に、生成AIの使い方、懸念、研修の希望を尋ねた横断調査だ。直近6か月に使ったのは48.9%で、仕事上の疑問への回答（38.7%）や臨床向け文書の作成が多かった。懸念は、人の判断を優先したい（46.2%）、正確さ（45.7%）、倫理面（38.2%）の順だった。

施設に正式な生成AIの方針があるのは6.2%で、利用者や家族から同意を得たのは12.2%にとどまる。個人を特定できる情報を入力したことがないのは94.8%。研修は必要と考える人が68.3%いる一方、42.2%は受けておらず、73.2%はウェビナー形式を望んでいる。自己申告で、日本の制度とは異なる。



出典 Am J Occup Ther ↗

短信

〈多発性硬化症〉 **多発性硬化症の理学療法と障害改善**
ドイツ登録の362組比較。理学療法ありで障害改善が多い（16.3%対11.1%）。観察研究。 出典 PubMed ↗

〈サルコペニア〉 **透析患者への看護師主導の運動**
透析患者56人の群ランダム化試験。補正後は有意差なし。重い有害事象なし。 出典 PubMed ↗

〈心不全〉 **心不全の遠心性自転車運動を比較**
心不全70人のRCT。両群で最大酸素摂取量が向上、TUGは遠心性のみ短縮。 出典 PubMed ↗

〈VR〉 **没入型VRの上肢への効果をメタ解析**
RCT10件367人。上肢機能SMD0.56（95%CI 0.17～0.95）。異質性が大きい。 出典 PubMed ↗

〈嚥下〉 **心不全に伴う嚥下障害の整理**
36報のレビュー。心不全の20%超に嚥下障害があり、非自宅退院や死亡と関連。 出典 PubMed ↗

〈高齢者〉 **運動と栄養の併用が最も有効**
47研究のNMA。複合運動と栄養の併用がTUGを最も短縮（ES -1.88）。 出典 PubMed ↗

〈失語症〉 **失語症の友人関係を守る訓練の試作**
失語症の人と友人向けの訓練ANCHORの試作。デジタルと対面を併用。効果は未検証。 出典 PubMed ↗

〈転倒予防〉 **外来の理学療法向けにSTEADIを適応**
外来の理学療法向けにSTEADIを修正。対象の選び方など核となる要素は変えず。 出典 PubMed ↗